



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA BULAN JUNI
INSTALASI GIZI
TAHUN 2026**

I. SDM

I.1. Ketenagaan

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	JUNI 2026	Kebutuhan	
Ka. Penunjang Medik	1	1	0	Lampiran
Ka. Unit	1	1	0	Lampiran
Pelaksana Gizi	4	4	0	Lampiran
Pelaksana Dapur	10	10	0	Lampiran

I.2. Pemenuhan Kualifikasi SDM

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi				Keterangan
	Standar	Kondisi saat ini	PPI dasar	Komunikasi Efektif	Penanggulangan Bencana	BHD	
Ka. Unit	D3/S1	D3	+	+	+	+	Internal
Pelaksana	D3 D4 S1	D3 D4 S1	+	+	+	+	Internal
Penyaji	SMA/K	SMA/K	+	-	+	+	Internal
Pengolahan	D1, SMA/K	SMP/S MA/K	+	-	+	+	Internal
Pemorsian	D1, SMA/K	SMA/K	+	-	+	+	Internal

I.3. Orientasi

Terdapat 2 orientasi karyawan baru pada Bulan Juni 2026

I.4. Pendidikan dan Pelatihan

Tidak terdapat diklat pada Bulan Juni 2026

I.5. Evaluasi kinerja Staf

Dilakukan evaluasi kinerja baik SDM maupun pelayanan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara OPPE oleh bagian SDM setiap 1 semester.

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

No.	Kegiatan Pengembangan Pelayanan	Rincian Kegiatan
1.	QC sesuai sistem HACCP	a. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. b. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. c. Memastikan 7 prinsip HACCP. d. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.
2.	Pemesanan diet melalui Whatsapp dan spreadsheet	a. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet.

No.	Kegiatan Pengembangan Pelayanan	Rincian Kegiatan
		b. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di grup whatsapp jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. c. Proses cetak label langsung efisien sesuai dengan diet ter update

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

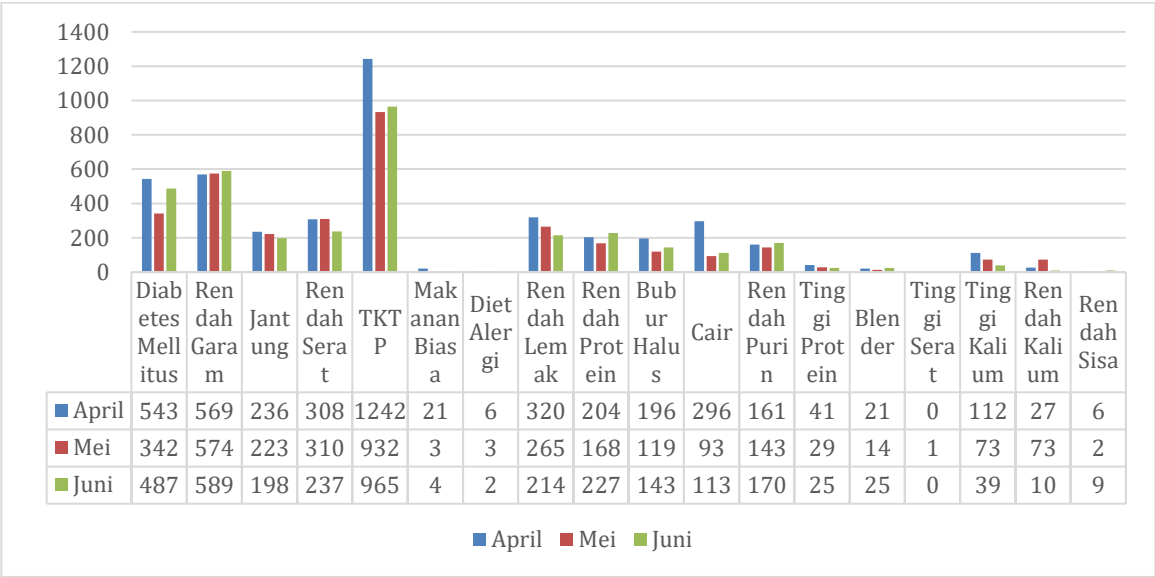
III.1. Pemberian Diet Pasien

(Perhitungan berdasarkan data pemberian diet pasien di rawat inap)

Tabel 3.1. Jumlah Pesanan Diet pada Bulan Mei Tahun 2026

No .	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	
1.	Diabetes Mellitus	543	342	487	42,4
2.	Rendah Garam	569	574	589	2,6
3.	Jantung	236	223	198	-11,2
4.	Rendah Serat	308	310	237	-23,5
5.	TKTP	1242	932	965	3,5
6.	Makanan Biasa	21	3	4	33,3
7.	Diet Alergi	6	3	2	-33,3
8.	Rendah Lemak	320	265	214	-19,2
9.	Rendah Protein	204	168	227	35,1
10.	Bubur Halus	196	119	143	20,2
11.	Cair	296	93	113	21,5
12.	Rendah Purin	161	143	170	18,9
13.	Tinggi Protein	41	29	25	-13,8
14.	Blender	21	14	25	78,6
15.	Tinggi Serat	0	1	0	-100,0
16.	Tinggi Kalium	112	73	39	-46,6
17.	Rendah Kalium	27	73	10	-86,3
18.	Rendah Sisa	6	2	9	350,0
Jumlah		4309	3321	3457	4,1

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Pesanan Diet di Unit Gizi Pada Bulan Juni 2026



Analisis : Jumlah pemesanan diet pasien rawat inap meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pasien di rawat inap. Jumlah pemesanan diet meningkat 4,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Beberapa jenis diet yang meningkat pada bulan Juni adalah diet DM, Rendah Garam, TKTP, Rendah protein, dan rendah purin

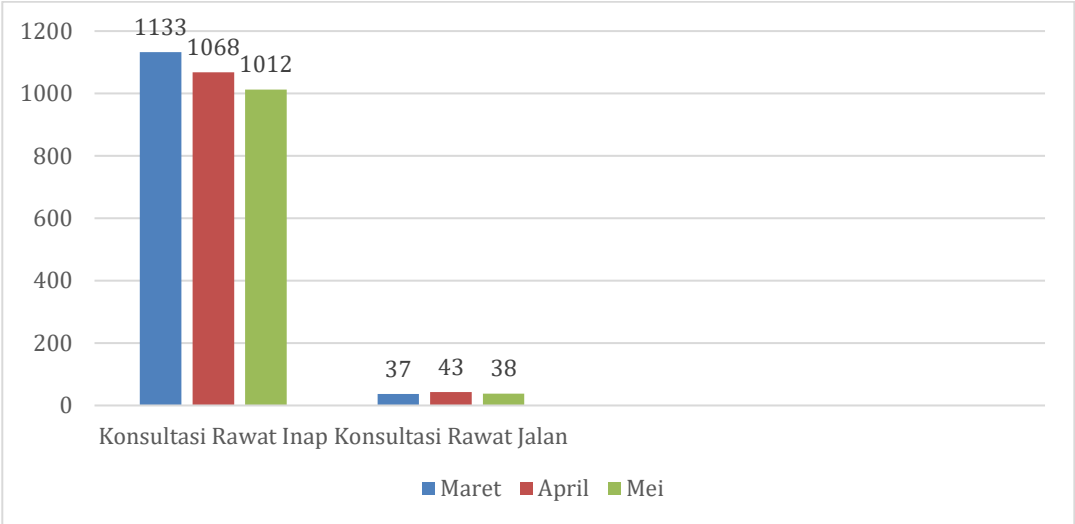
RTL : Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu dan mutu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

III.2. Jumlah Konsultasi Gizi

Tabel 3.2 Jumlah Konsultasi Gizi

No.	Indikasi	Jumlah Pasien April 2026	Jumlah Pasien Mei 2026	Jumlah Pasien Juni 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	1133	1068	1012
2.	Konsultasi Rawat Jalan	37	43	38

Gambar 3.2 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis : Jumlah konsultasi gizi rawat inap dan jalan pada bulan Juni menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ard hany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

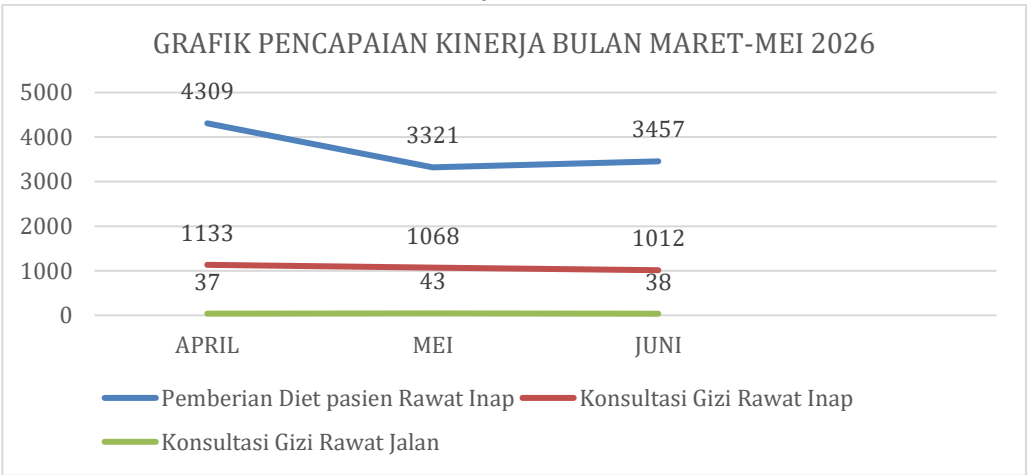
RTL : Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

III.3. Pencapaian Kinerja Gizi

Tabel 3.3. Pencapaian kinerja gizi dari Bulan Januari – Maret 2026

Kegiatan	APR 26	MEI 26	JUNI 26	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)	JUNI 25	% Capaian Bulan Jan 2026 : 2025
Pemberian Diet pasien Rawat Inap	4309	3321	3457	4,0 (↓)	2981	15,9 (↑)
Konsultasi Gizi Rawat Inap	1133	1068	1012	5,4 (↓)	1054	3,9(↑)
Konsultasi Gizi Rawat Jalan	37	43	38	-11,6 (↑)	20	50 (↓)

Gambar 3.3 Grafik Pencapaian Kinerja Gizi



Analisis : Konsultasi gizi rawat inap bulan Juni 2026 menurun dibandingkan bulan Mei. Konsultasi gizi rawat jalan bulan Juni 2026 menurun karena beberapa DPJP jarang memberikan rujukan ke poli gizi (hanya beberapa poli seperti poli jantung dan IPD) diberikan rujukan saat pasien bertanya terkait pantangan makan yang dijalankan oleh pasien saat control ke polinya.

RTL : Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien

terhadap variasi menu makanan. Mengajukan revisi siklus makan pasien untu meningkatkan variasi menu.

Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi. Memberikan contoh resep masakan dalam leaflet edukasi diet pasien.

III.4. Diet IRNA

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Produktivitas Pemberian Diet Rawat Inap RSPHM Bulan Januari s/d Mei 2026

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SR T	TKTP	BIASA	ALERG I	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
1.	Des'25	526	580	308	349	1130	38	6	329	286	209	106	177	42	33	0	64	22	3
	Jan'26	454	561	345	237	1092	19	0	312	232	143	117	197	36	23	0	59	7	4
	Analisis	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah px yang rawat inap dengan diet tersebut meningkat	Pemberian diet rendah serat menurun karena diagnosa TF dan GEA sedikit .	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosa dengan diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Tidak terdapat pasien alergi	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mampu menyalur	Pasien yang membutuhkan diet tinggi protein tidak banyak. Karena albuminnya normal .	Pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut ada	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut ada	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut ada	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium menurun karena sedikit pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa karena post hemoroid agar tidak BAB dulu.

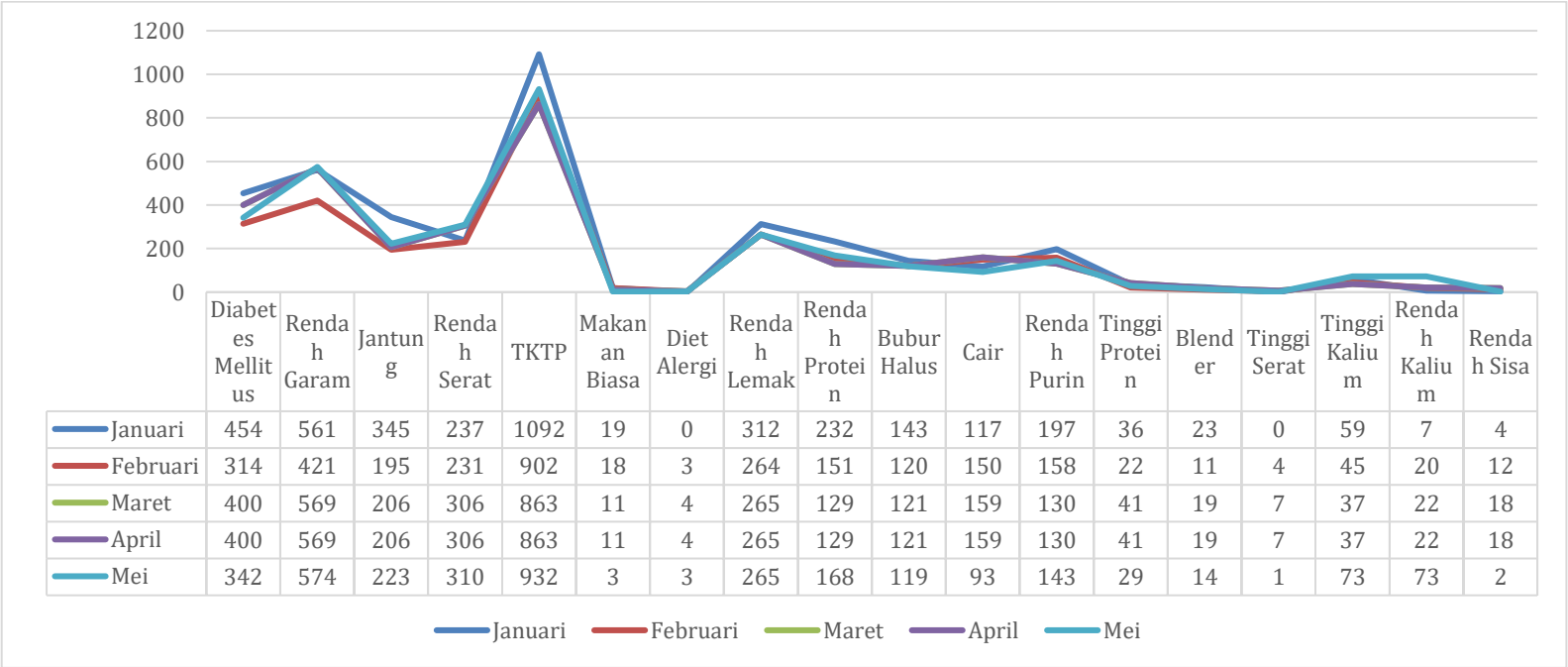
NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SR T	TKTP	BIASA	ALERG I	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
2.	Jan'26	454	561	345	237	1092	19	0	312	232	143	117	197	36	23	0	59	7	4
	Feb'26	314	421	195	231	902	18	3	264	151	120	150	158	22	11	4	45	20	12
	Analisis	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Pemberian diet rendah serat menurun karena diagnosis TF dan GEA sedikit.	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosis diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mapuh mengunyah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak banyak. Karena albuminnya normal.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Terdapat pasien konstipasi sehingga diet T. Serat meningkat	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium meningkat karena banyak pasien dengan diagnosis hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa meningkat karena post hemoroid atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PRN	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
3.	Feb'26	314	421	195	231	902	18	3	264	151	120	150	158	22	11	4	45	20	12
	Mar'26	400	569	206	306	863	11	4	265	129	121	159	130	41	19	7	37	22	18
	Analisis	Diet DM meningkat seiring diagnosa diabetes mellitus	Diet rendam meningkat seiring diagnosa hipertensi	Diet jantung meningkat seiring diagnosa tersebut	Pemberian diet rendah serat meningkat karena diagnosa GEA meningkat.	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosa dengan diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mampu menyang	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang butuh diet tinggi protein meningkat, Diet tersebut seiring pasien pasca bedah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Terdapat pasien konstipasi sehingga diet T. Serat meningkat	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium meningkat karena banyak pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa meningkat karena post hemoroid atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SR T	TKTP	BIASA	ALERG I	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
4.	Mar'26	400	569	206	306	863	11	4	265	129	121	159	130	41	19	7	37	22	18
	Apr'26	543	569	236	308	1242	21	6	320	204	196	296	161	41	21	0	112	27	6
	Analisis	Pem beria n Diet DM meni ngka t seirin g diag nosa diab etes militu s	Pemb erian Diet renda hgara m tidak menin gkat pada bulan april	Pemb erian Diet jantun g menin gkat seiring menin gkatny a diagno sa yang berkait an denga n jantun g	Pemb erian diet renda h serat menin gkat karena diagno se yang memb utuhka n diet terseb ut menin gkat yait pasien denga n operas i	Pemb erian diet TKTP menin gkat karena diagno se yang memb utuhka n diet terseb ut menin gkat yait pasien denga n operas i	Diet yang membut uhkan diet biasa menin gkat seperti diet untuk ibu bayi dibawah 6 bulan	Terdapa t pasien dengan alergi makana n	Jumla hpeme san an diet renda h lemak menin gkat seiring denga n menin gkatny a pasien denga n profil lipid yang menin gkat	Jumla h pasien yang memb utuhka n diet renda h protein menin gkat berkait an denga n menin gkatny a hasil lab (Ur, BUN, Cr) menin gkat	Jumla h pasien yang rawat inap denga n diagno sa yang memb utuhka n diet tersew but menin gkat seperti pasien post op	Pasien yang memb utuhka n diet cair menin gkat karena terdap at pasien yang penur unan kesad aran dan tidak mapuh mengu nyah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnos a hasil lab UA tinggi menin gkat.	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak menin gkat	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menin gkat yaitu pasien anak dengan usia dibawah 6 bulan	Tidak terdap at pasien konsti pasi sehing ga tidak ada pemes anan diet T. Serat	Pasien yang membut uhkan diet tinggi kalium menin gkat dikaren akan banyak pasien dengan diagnos a hiperkal emia. n	Pasien yang membut uhkan diet rendah kalium menin gkat dikaren akan banyak pasien dengan diagnos a hiperkal emia. n	Adanya pasien yang diberika n diet rendah sisa karena post hemoroi d atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SR T	TKTP	BIASA	ALERG I	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
6	Mei'26	342	574	223	310	932	3	3	265	168	119	93	143	29	14	1	73	27	2
	Jun'26	487	589	198	237	965	4	2	214	227	143	113	227	25	25	0	39	10	9
	Analisis	Pem beria n Diet DM meni ngka t seirin g diag nosa diab etes militu s	Pemb erian Diet renda hgara m menin gkat pada bulan juni	Pemb erian Diet jantun g menur un seiring menur unnya diagno sa yang berkait an denga n jantun g	Pemb erian diet renda h serat menin gkat karena diagno se yang memb utuhka n diet terseb ut menin gkat yait pasien denga n operas i	Pemb erian diet TKTP menin gkat karena diagno se yang memb utuhka n diet terseb ut menin gkat yait pasien denga n operas i	Diet yang membut uhkan diet biasa meningk at seperti diet untuk ibu bayi dibawah 6 bulan	Terdapa t pasien dengan alergi makana n	Jumla h pemes anan diet renda h lemak menur un seiring denga n menur unnya pasien denga n profil lipid yang menin gkat	Jumla h pasien yang memb utuhka n diet renda h protein menin gkat berkait an denga n menin gkatny a hasil lab (Ur, BUN, Cr) menin gkat	Jumla h pasien yang rawat inap denga n diagno sa yang memb utuhka n diet tersew but menin gkat seperti pasien post op	Pasien yang memb utuhka n diet cair menin gkat karena terdap at pasien yang penur unan kesad aran dan tidak mapuh mengu nyah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnos a hasil lab UA tinggi menin gkat.	Pasien yang butuh diet tinggi protein menur un	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menin gkat yaitu pasien anak dengan usia dibawah 6 bulan	Tidak terdap at pasien konsti pasi sehing ga tidak ada pemes anan diet T. Serat	Pasien yang membut uhkan diet tinggi kalium menin gkat dikaren akan banyakn ya pasien dengan hasil lab kalium menuru n	Pasien yang membut uhkan diet rendah kalium menuru n karena sedikit pasien dengan diagnos a hiperkal emia.	Adanya pasien yang diberika n diet rendah sisa karena post hemoroi d atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

Gambar 3.4. Grafik Pencapaian Kinerja Produktivitas Pemberian Diet Rawat Inap RSPHM Bulan Januari s/d Juni 2026



Analisis : Pada bulan Juni pemberian diet pasien sebagian besar mengalami peningkatan dikarenakan beberapa pasien mendapatkan jenis diet yang komplit tergantung dari diagnosa dan hasil laboratorium pasien. Akan tetapi beberapa pemberian diet yang mengalami peningkatan adalah pemberian diet DM, RG, dan Rendah serat karena banyaknya pasien dengan keluhan terkait diagnosa tersebut.

RTL : Koordinasi dengan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien, dan meningkatkan kualitas pemberian diet pasien sesuai dengan kebutuhannya.

III.5 Permasalahan Unit

Tabel 3.5 Permasalahan Unit

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian	P	Alur penyerahan alat makanan harus bebas dari kontaminasi untuk menjamin higiene sanitasi alat makanan
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan IPSRS dalam pembuatan alur yang sesuai
		S	Risiko alat makan terkontaminasi makanan mentah sehingga tidak terjaga kebersihannya
		A	Tim gizi dan IPSRS berkolaborasi dalam pembuatan alur yang sesuai untuk penyerahan alat makan bersih ke tempat pemorsian
2	E-RM poli rawat jalan gizi masih belum terlaksana	P	Pemberian asuhan gizi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penulisan CPPT
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, programmer, dan pihak management RS dalam realisasi penulisan E-RM Poli gizi
		S	Risiko pemberian asuhan gizi tidak terintegrasi dan tidak adanya bukti ahli gizi telah melakukan edukasi kepada pasien rujukan poli dokter spesialis
		A	Tim gizi , programmer, dan pihak managemen RS dalam realisasi penulisan ERM Gizi
3	Jarak rak penyimpanan bahan makanan kering kurang dari 15 cm	P	Menurunkan suhu freezer daging sehingga memperpanjang masa simpan daging dan menjaga kualitas daging agar tidak busuk
		D	Melakukan koordinasi dengan tim IPSRS untuk mengatur settingan freezer agar suhu freezer sesuai dengan standar yaitu $\leq -5^{\circ}\text{C}$
		S	Risiko daging sapi mengalami pembusukan
		A	Tim gizi, IPSRS, yang bekerjasama dalam mengontrol suhu penyimpanan daging
4	Suhu Freezer daging meningkat sehingga daging di dalam freezer tidak beku dan mengeluarkan bau menyengat	P	Menurunkan suhu freezer daging sehingga memperpanjang masa simpan daging dan menjaga kualitas daging agar tidak busuk
		D	Melakukan koordinasi dengan tim IPSRS untuk mengatur settingan freezer agar suhu freezer sesuai dengan standar yaitu $\leq -5^{\circ}\text{C}$
		S	Risiko daging sapi mengalami pembusukan
		A	Tim gizi, IPSRS, yang bekerjasama dalam mengontrol suhu penyimpanan daging

IV. FASILITAS KESEHATAN DAN K3

IV.1. Fasilitas Kesehatan

4.1.1 Inventaris alat Unit Gizi

Tabel 4.1.1.a Inventaris alat Unit Gizi (Kantor Gizi)

No .	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Monitor (Set Pc)	1	Baik	-	-
2.		Cpu (Set Pc)	1	Baik	-	-
3.		Keyboard (Set Pc)	1	Baik	-	-
4.		Printer	1	Baik	-	-
5.		Smoke Detector	1	Rusak	-	Utilitas central rusak
6.		AC (1 PK)	1	Baik	-	-
7.		Mouse	1	Baik	-	-
8.		Kursi Kantor Roda	1	Baik	-	Melakukan pembusakan ulang kursi kantor roda kolaborasi dengan tim MFK
9.		Kursi Plastik Coklat	3	Baik	-	-
10.		Kursi Plastik Hijau	2	Baik	-	-
11.		Meja Kerja	1	Baik	-	-
12.		Lemari Rak File	2	Baik	-	-
13.		Lemari Kayu	1	Baik	-	-
14.		Lemari Besi	1	Baik	-	-
15.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
16.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
17.	Non medis – Non Listrik	Papan IPD	1	Baik	-	-
18.		Box File	4	Baik	-	-
19.		Laci Plastik Atk Mini	1	Baik	-	-
20.		Cutter	1	Baik	-	-
21.		Double Tape	1	Baik	-	-
22.		Gunting	1	Baik	-	-
23.		Isolasi Bening	3	Baik	-	-
24.		Kalkulator	1	Baik	-	-
25.		Odner Hitam	5	Baik	-	-
26.		Karada Scan Body Composition	1	Baik	-	-
27.		Rak Plastik Susun 4	1	Baik	-	-
28.		Plong-Plongan	1	Baik	-	-
29.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-

Ruang Poli Gizi						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	AC	1	Baik	-	-
2.		Monitor	1	Tidak pakai		
3.		Meja Kerja	1	Baik	-	-
4.		Kursi Kerja	1	Baik	-	-
5.	Non medis –Non Listrik	Kursi Pasien	2	Baik	-	-
6.		Box Food Model	1	Baik	-	-
7.		Food Model	1 set	Baik	-	-
8.		Lemari Penyimpanan	1	Baik	-	-
9.		Tumpeng Gizi Seimbang	1	Baik	-	-

10.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
11.		Microtoa	1	Baik	-	-
12.		Wastafel	1	Baik	-	-

Tabel 4.1.1.b Inventaris Alat Unit Gizi (Dapur)

Ruang Pencucian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Dishwasher	1	Baik	-	-
2.		Kipas Angin	2	Baik	-	-
3.		Exhaust Fan 40x40	1	Baik	-	-
4.	Non medis – Non Listrik	Kitchen Sink Greasetrap	1	Baik	-	-
5.		Rak Besi Susun 4	1	Baik	-	-
6.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
7.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
8.		Tray cuci	5	Baik	-	-
9.		Bak Peniris	3	Baik	-	-
10.		Gas Duck Roaster	1	Baik	-	-
11.		Heavy Duty Rice Cooker	1	Baik	-	-

Ruang Penerimaan Bahan Makanan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Showcase polytron	1	Baik	-	-
2.		Kipas Angin	1	Baik	-	-
3.		Insect Killer	1	Baik	-	-
4.	Non medis – Non Listrik	Kitchen Sink	2	Baik	-	-
5.		Rak Besi Susun 3	1	Baik	-	-
6.		Meja Penerimaan	1	Baik	-	-
7.		Loker Petugas Dapur	1	Baik	-	-
8.		Wastafel	1	Baik	-	-
9.		Timbangan Besi Duduk	1	Baik	-	-
10.		Timbangan Analog	1	Baik	-	-
11.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
12.		Rak Barang 5 Susun	1	Baik	-	-
13.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
14.		Box K3	1	Baik	-	-
15.		Tirai pvc	1	Baik	-	-

Ruang Pemorsian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Insect Killer	2	Baik	-	-
2.		AC	1	Baik	-	-
3.		Sealer	1	Baik	-	-
3.		Meja Pemorsian Besi	6	Baik	-	-
4.	Non medis – Non Listrik	Piring Makan Persegi Melamin Pasien Vip	40	Baik	-	-
5.		Mangkok Kecil Melamin	78	Baik	-	-
6.		Box Makan Pasien Dewasa	178	Baik	-	-
7.		Box Makan Pasien Anak	28	Baik	-	-

Ruang Pemorsian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
8.		Plato Makan Pasien Anak	10	Baik	-	-
9.		Plato makan anak	68	Baik	-	-
10.		Gelas Pasien	122	Baik	-	-
11.		Tutup gelas	108	Baik		
12.		Sendok Pasien	154	Baik	-	-
13.		Sendok Snack	38	Baik		
14.		Mangkok Dokter	62	Baik	-	-
15.		Piring makan pasien persegi	52	Baik	-	-
16.		Piring snack persegi	79	Baik	-	-
17.		Mangkuk sayur	102	Baik	-	-
18.		Box makan merah	178	Baik	-	-
19.		Piring dessert	12	Baik	-	-
20.		Gelas melamin dokter	13	Baik	-	-
21.		Gelas keramik dokter	24	Baik	-	-
22.		Bel	1	Baik	-	-
23.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
24.		Wastafel	1	Baik	-	-
25.		Tempat Tisu	1	Baik	-	-
26.		Troli Makanan	9	Baik	-	-
29.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-

Ruang Penyimpanan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Freezer Midea	1	Baik	-	-
2.		Freezer Modena	1	Baik	-	-
3.		Showcase Politron	1	Baik	-	-
4.		Kipas Angin Kdk	1	Baik	-	-
5.		Exhaust	3	Baik	-	-
6.		Kipas Angin Miyako	1	Baik	-	-
7.	Non medis –Non Listrik	Tray Pvc	1	Baik	-	-
8.		Thermohygrometer	4	Baik	-	-
9.		Lemari Rak Susun 4	4	Baik	-	-
10.		Ember Penyimpanan Beras	1	Baik	-	-
11.		Ember Penyimpanan Gula	1	Baik	-	-
12.		Box Kontainer Hitam	8	Baik	-	-
13.		Box Kontainer Transparan	8	Baik	-	-
14.		Toples Besar Transparan	2	Baik	-	-

Ruang Pengolahan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Magic Com	2	Baik	-	-
2.		Showcase Cooler merk GEA	1	Baik	-	-
3.		Blower	1 set	Baik	-	-

Ruang Pengolahan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
4.		Oven	1	Baik	-	-
5.		Blender	2	Baik	-	-
6.		Food Prosesor	1	Baik	-	-
7.		Insect Killer	1	Baik	-	-
8.	Non medis –Non Listrik	Rak Besi Susun 3	3	Baik	-	-
9.		Meja Besi Pengolahan	1	Baik	-	-
10.		Meja Kompor	1	Baik	-	-
11.		Kompor Rinai 2 Tungku	1	Baik	-	-
12.		Kompor Besar 1	1	Baik	-	-
13.		Kompor Stockpot	2	Baik	-	-
14.		Kitchen Sink	2	Baik	-	-
15.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
16.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
17.		Panci Besar	6	Baik	-	-
18.		Panci Kecil	4	Baik	-	-
19.		Apron	15	Baik	-	-
20.		Presto	3	Baik	-	-
21.		Peniris Minyak	5	Baik	-	-
22.		Termos Nasi Besar	4	Baik	-	-
23.		Pisau	16	Baik	-	-
24.		Talenan	3	Baik	-	-
25.		Spatula	9	Baik	-	-
26.		Cetakan Pukis	2	Baik	-	-
27.		Sendok Sayur	4	Baik	-	-
28.		Baskom Besar	2	Baik	-	-
29.		Baskom Kecil	2	Baik	-	-
30.		Wajan	10	Baik	-	-
31.		Baki Pasien	23	Baik	-	-
32.		Teflon	3	Baik	-	-
33.		Telepon Dapur	1	Baik	-	-
34.		Lemari Kayu	1	Baik	-	-
35.		Tirai Pvc	1	Baik	-	-
36.		Toples plastic 1500 ml	3	Baik	-	-
37.		Smoke Detector	1	Baik	-	-

4.1.2 Kalibrasi
Tabel 4.1.2 Kalibrasi Alat

No .	Nama Alat	No. Seri	Frekuensi			Terakhir Kalibrasi	PJ
			Minggu	Bulan	Tahun		
1.	-						

4.1.3 Penambahan alat baru
Tabel 4.1.3 Penambahan Alat baru

No.	Nama Alat	Jumlah	No. Inventaris	No. Seri	Tanggal Pengajuan	Tanggal Barang Datang
1.	-	-	-	-	-	-

4.1.4 Alat rusak

Tabel 4.1.4 Alat Dan Fasilitas Rusak

No.	Nama Alat	Jumlah	No. Inventaris	No. Seri	Penyebab Rusak	Tanggal Lapor	Tanggal Selesai
1.	-	-	-	-	-	-	-

IV.2. GEDUNG DAN BANGUNAN

Tabel 4.2 Gedung dan Bangunan

No.	Nama Unit	Luas Gedung (M ²)
1.	Instalasi Gizi	12,9 x 8,57
2.	Ruang Trolley Makanan	5,35 x 2,5

No.	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1.	Pemeliharaan alat & bangunan	a. Pada bulan ini dilakukan pembersihan rutin ruangan setiap hari. b. Ruang pemorsian yang ada saat ini tidak sesuai karena berada di lorong (akses jalan) hal tersebut sangat tidak disarankan karena akses jalan menjadi 1 arah, sementara standar bangunan di unit gizi harus 2 arah (pintu masuk dan keluar dibedakan). c. Ruang persiapan (untuk mempersiapkan bahan makanan dari pemotongan hingga siap diolah), selama ini petugas jika memotong sayuran dll dilakukan di ruang penerimaan bahan makanan dikarenakan belum tersedianya ruang persiapan. d. Belum tersedianya ruang perpustakaan mini di unit gizi guna menunjang ilmu terupdate terkait gizi. e. Alur penyerahan alat makan bersih ke ruang pemorsian masih belum standar karena melewati ruang pengolahan f. Gudang kering masih belum sesuai standart jarak rak dari dinding.
2.	Perbaikan sarana & prasarana	a. Ruang persiapan (untuk mempersiapkan bahan makanan dari pemotongan hingga siap diolah), selama ini petugas jika memotong sayuran dll dilakukan di ruang penerimaan bahan makanan dikarenakan belum tersedianya ruang persiapan. b. Belum tersedianya ruang perpusatakaan mini di unit gizi guna menunjang ilmu terupdate terkait gizi. c. Alur keluar masuk petugas gizi atau petugas lain yang akan ke unit gizi 1 arah yaitu melalui pintu pencucian peralatan makan pasien dan ruang pengolahan makanan.

No.	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
		d. Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian

IV.3. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tabel 4.3. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

No.	Kegiatan Pokok	Jumlah	Keterangan
1.	Monitoring Kesehatan	-	a. Terdapat pemeriksaan kesehatan pada bulan Januari 2026 (rectal swab) b. Tidak dilakukan imunisasi pada bulan ini.
2.	PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	-	a. Pemberian makanan tambahan di berikan setiap hari Jum’at (Jum’at Berkah) b. Pemberian buka puasa dan takjil untuk seluruh karyawan shift MD dan sore setiap bulannya c. Pemberian PMT kepada unit khusus seperti unit radiologi dan unit isolasi lantai 5
3.	Mangkir Kerja		
	a. Cuti	-	-
	b. Sakit	-	-
	c. Alpha	-	-
4.	Konseling	-	Konseling kedisiplinan dalam memberikan label makanan saat disimpan di showcase snack kepada seluruh petugas di instalasi gizi
5.	Penyakit akibat kerja /kecelakaan kerja	-	-

Analisis :

- Pemberian makanan tambahan bagi karyawan berupa jumat berkah diberikan secara rutin
- Pemberian makanan tambahan bagi karyawan yang berbuka puasa diberikan dengan cara karyawan yang berpuasa melakukan pemesanan makanan buka 1 hari sebelum berbuka.
- Pemberian makanan tambahan juga diberikan kepada unit berisiko seperti unit radiologi.
- Konseling penyimpanan makanan setengah matang diberikan karena masih terdapat petugas yang tidak disiplin memberikan tanggal pembuatan makanan setengah matang, dan matang dan belum patuh pelabelan.
- Konseling penggunaan APD dikarenakan masih ada petugas yang tidak disiplin dalam menggunakan APD masker bagi tim pengolahan dan penyaji serta seragam bagi tim pengolahan.
- Konseling PPI, peningkatan kemampuan pegawai dan merefresh materi setiap minggunya.

RTL :

- Sosialisasi kepada seluruh petugas instalasi gizi (Ahli gizi, pengolahan, dan penyaji) untuk menjaga kesehatan dengan cara istirahat cukup dan memperbaiki pola makan agar tidak gampang terkena penyakit.
- Sosialisasi pemberian label pada makanan setengah matang sebagai pengaktifan sistem FIFO agar makanan yang dibuat lebih dulu dapat digunakan lebih dulu untuk

- mencegah makanan setengah matang rusak dan dapat berdampak pada mutu makanan secara rasa dan tampilan
3. Sosialisasi penggunaan APD untuk melindungi diri dan melindungi makanan agar terjaga kebersihannya

V. MUTU

Tabel 5.1. Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi

No.	Pengukuran	Standar	Hasil
1.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	83,7%
2.	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%
3.	Angka kelengkapan pengkajian gizi	100%	99,8%
4.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	3
5.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0
6.	Kejadian makanan basi	0	0

Analisis :

1. Tanggal 1 Juni 2026 Pasien Ahmad hadi (C2A-1), pasien ob datang tgl 31 Mei jam 14.19 sehingga belum diberikan diet oleh ahli gizi, penyaji Duwi Ratna pada waktu membagi makan pagi tidak bertanya apakah pasien memiliki Dm atau tidak seperti update pasien pada umumnya jika diketahui pasien OB, pada waktu pagi hari diberikan teh manis dan diberikan snack non DM (setup pisang) yang menyebabkan gula darah pasien naik.
2. Tanggal 16 Juni 2026 Pasien Supinah (B5C-2) tidak derikan diet DM sejak MRS oleh ahli gizi (nurdyna) padahal ahli gizi sudah tau jika pasien memiliki RPD DM, diketahui saat ada pergantian diet menjadi cair sonde/NGT
3. Tanggal 22 Juni 2026 pasien Sukemi (D8A-9) memiliki hasil lab Gula darah Sewaktu tinggi yaitu 284 mg/dl. Akan tetapi oleh ahli gizi Najiyyatul diberikan diet TKTP RG yang seharusnya jika pasien GDS tinggi diberikan diet DM.

RTL :

1. Memberikan teguran langsung kepada setiap petugas yang tidak menggunakan APD dengan lengkap
2. Memberikan teguran berupa evaluasi kinerja kepada ahli gizi dan penyaji terkait ketidak patuhan dalam menyediakan diet kepada pasien dengan tepat.
3. Melakukan evaluasi terkait pemetaan ruangan saat keliling ruangan agar dapat mendahulukan pasien yang akan pulang untuk dilakukan pengkajian gizi agar tidak ada pasien yang terlewat dalam pemberian pengkajian gizi

VI. Manajemen Risiko

No	Jenis Risiko	Grading Risiko	Pengendalian Risiko	Jumlah Kejadian	Keterangan
Keselamatan					
1	Stress Kerja	Tinggi	Sosialisasi beban kerja	0	-
2	Terjatuh	Tinggi	Lantai tidak licin dan penandaan risiko	0	-
3	Terkena minyak panas	Tinggi	Penggunaan APD	0	-
4	Tersengat listrik	Tinggi	Penandaan risiko dan kabel rapih	0	-
5	Tersayat ATK	Moderate	Kewaspadaan petugas	0	-
Keamanan					
6	Terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR	0	-
7	Kehilangan	Moderate	Adanya lemari terkunci	0	-
B3					
8	Tumpahan B3 ATK	Ringan	Penyediaan spilkit B3	0	-
9	Tumpahan cairan B3	Tinggi	Pengamanan ruang yang aman	0	-
10	Kebocoran Gas	Tinggi	Pengamanan ruang yang aman	0	-
Kebakaran					
11	Konsleting listrik	Tinggi	Pemeriksaan listrik berkala	0	-
12	Kompor terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR	0	-
13	Bahan kimia mudah terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR yang aman	0	-
Kedaruratan Bencana					
14	Kebakaran	Tinggi	Penyediaan fire protektive	0	-
15	Gempa Bumi	Tinggi	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah	0	-
16	Keracunan Makanan	Tinggi	Pemilahan bahan makanan yang bersih dan sesuai	0	-
Sistem Utilitas					

17	Kegagalan Listrik	Tinggi	Penggunaan genset	0	-
18	Kegagalan air bersih	Tinggi	Back up air bersih	0	-
19	Kegagalan jaringan internet	Ringan	Back up jaringan internet	0	-
20	Kegagalan SIMRS	Ringan	Back up data manual	0	-
Penanganan Darurat Bencana					
21	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	Moderate	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster	0	-
Konstruksi dan Renovasi					
22	Tembok retak	Tinggi	Pembangunan yang sesuai	0	-
23	Plafon retak	Tinggi	Pembangunan yang sesuai	0	-
24	Ruangan sempit	Ringan	Pembangunan yang sesuai	0	-
25	Ventilasi kurang	Moderate	Pembangunan yang sesuai	0	-
Pelatihan					
26	Tidak mengikuti pelatihan bencana	Moderate	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku	0	-
27	Tidak ada pelatihan tata boga	Moderate	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku	0	-
28	STR dan SIP mati	Moderate	Perpanjangan STR dan SIP	0	-
Lingkungan					
29	Adanya semut	Tinggi	Area bersih dan pemberian perangkap	0	-
30	Adanya tikus	Tinggi	Area bersih dan pemberian perangkap	0	-

Tabel 5.2. Laporan Insiden Keselamatan / Manajemen Risiko

No .	Jenis IKP	Ringkasan Kronologi & Tindak Lanjut
1.	KTD	Tanggal 1 Juni 2026 Pasien Ahmad hadi (C2A-1), pasien ob datang tgl 31 Mei jam 14.19 sehingga belum diberikan diet oleh ahli gizi, penyaji Duwi Ratna pada waktu membagi makan pagi tidak bertanya apakah pasien memiliki Dm atau tidak seperti update pasien pada umumnya jika diketahui pasien OB, pada waktu pagi hari diberikan teh manis dan diberikan snack non DM (setup pisang) yang menyebabkan gula darah pasien naik.
2.	KTC	Tanggal 16 Juni 2026 Pasien Supinah (B5C-2) tidak derikan diet DM sejak MRS oleh ahli gizi (nurdyna) padahal ahli gizi sudah tau jika pasien memiliki RPD DM, diketahui saat ada pergantian diet menjadi cair sonde/NGT
3	KTC	Tanggal 22 Juni 2026 pasien Sukemi (D8A-9) memiliki hasil lab Gula darah Sewaktu tinggi yaitu 284 mg/dl. Akan tetapi oleh ahli gizi Najiyatul diberikan diet TKTP RG yang seharusnya jika pasien GDS tinggi diberikan diet DM.

Analisis :
Beberapa kesalahan pemberian diet terjadi karena adanya keteledoran dari petugas. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya ketelitian dan komunikasi eektif petugas.

- RTL :
- 1. Memberi edukasi kepada ahli gizi agar lebih berhati-hati dalam menentukan diet pasien.
 - 2. Memberi edukasi kepada penyaji agar lebih teliti dan membagi makanan sesuai dengan prosedur.

VII. PPI

Tabel 6.1. Data Hasil Monitoring Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di Unit Gizi April -Juni 2026

No.	Komponen PPI	Apr		Mei		Juni	
		Y	T	Y	T	Y	T
1.	Penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien	V		V		V	
2.	Proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis	V		V		V	
3.	Makanan yang disiapkan dan disimpan dengan mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan		V	V		V	
4.	Distribusi makanan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan	V		V		V	
5.	Jika ada keluarga pasien yang membawakan makanan, beri edukasi kepada keluarga tentang pembatasan diet pasien dan resiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi	V		V		V	
6.	Pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien beresiko gizi	V		V		V	

No.	Komponen PPI	Apr		Mei		Juni	
		Y	T	Y	T	Y	T
7.	Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi	V		V		V	
8.	Evaluasi dan monitoring terapi gizi dan dicatat di rekam medis pasien	V		V		V	
9.	Penulisan PPA dan staf klinis melakukan pengisian e-RM dengan lengkap dan jelas	V		V		V	
10.	Pelaksanaan penyimpanan, pengolahan, pemorsian, termasuk packing, distribusi, pencucian alat makan dan alat masak serta kebersihan dan sanitasi dapur	V		V		V	
11.	Pelaksanaan penyimpanan bahan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi resiko infeksi		V	V		V	
12.	Pengisian suhu ruangan, suhu lemari pendingin, suhu freezer, dan pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur	V		V		V	
13.	Kesesuaian <i>hand hygiene</i> setiap selesai melakukan kegiatan yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan <i>hand wash</i> dan <i>hand rubs</i>		V	V		V	
14.	Kelengkapan fasilitas <i>hand hygiene</i> antara lain sabun, desinfektan, serta tissue / handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan desinfeksi tangan	V			V		V
15.	Pelaksanaan pelatihan tentang <i>hand hygiene</i> untuk semua petugas gizi	V		V		V	
16.	Kepatuhan penggunaan APD	V			V		V
17.	Ketersediaan alat pelindung diri / APD	V		V		V	
Prosentase		82,3%		88,2%		88,2%	

Tabel 6.2. Kepatuhan PPI di Unit Gizi Tahun 2026

No.	Bulan	Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan		Audit Kepatuhan Pemakaian APD Unit
		Capaian OPP	Prosentase	Prosentase
1.	Januari	216	81,02%	100%
2.	Februari	288	81,25%	95%
3.	Maret	207	79,23%	96%
4.	April	216	81,94%	99%
5.	Mei	216	75,46%	99%
6.	Juni	223	78,83%	83,7%

Sumber : Link PPI audit HH dan surveilens mutu SIMRS

Analisis :

- 1) Petugas penjamah makanan sudah mulai menerapkan 5 momen cuci tangan, harus saling mengingatkan agar terbiasa menerapkan 5 momen cuci tangan. Agar pencapaian HH meningkat.
- 2) Beberapa petugas penyaji masih belum hafal 6 langkah cuci tangan yang benar
- 3) Kepatuhan penggunaan APD bulan Juni 2026 perlu lebih ditingkatkan pada petugas pengolahan. APD yang paling sering tidak digunakan adalah masker dan seragam.
- 4) Setiap seminggu sekali diadakan refresh terkait PPI.

RTL :

- 1) Kepatuhan penggunaan APD harus lebih diisiplinkan untuk menjaga makanan tetap higienis terutama petugas pengolahan.
- 2) Kepatuhan petugas dapur dan juga penjamah makanan harus lebih ditingkatkan lagi agar dikemudian hari tidak ada kontaminasi silang ke pasien karena ketidak patuhan petugas dengan cara sosialisasi pentingnya HH dan 5 momen.
- 3) Membersihkan lingkungan dapur setiap selesai kegiatan, meletakkan bahan makanan yang baru datang di tempat yang sudah ditentukan (bahan basah dimasukkan ke gudang beku, bahan kering dimasukkan kedalam gudang kering) dengan system FIFO dan FEFO.

VIII. PKRS

Tabel 7.1 PKRS Gizi

No .	EDUKASI	Target	Hasil	Media- Metode	TGL pelaksanaan	Tempat /KET
1.	Individu pasien Irna	100%	Pasien memahami edukasi yang disampaikan	Ceramah	Setiap Hari	Ruang IRNA
2.	Kelompok (penunggu, Pasien Irna, Pasien Poli, Komunitas	4x/bln	Peserta penyuluhan memahami materi yang diberikan	Ceramah	15,23,29,30 Juni 2026	Ruang Tunggu Poli

Analisis :

- 1) Edukasi di rawat inap diberikan kepada setiap pasien baru masuk. Selain itu edukasi diberikan kepada pasien dengan perubahan diet atau perubahan tekstur makanan pasien.
- 2) Edukasi kelompok diberikan kepada pasien rawat jalan dan keluarga pasien di ruang tunggu poli.
- 3) Edukasi kelompok dilaksanakan setiap seminggu sekali.
- 4) Materi yang diberikan adalah materi tentang diet pasien yang diberikan secara bergantian seperti diet DM, Rendah Protein, Rendah Lemak, Rendah Garam

RTL :

- 1) Bekerjasama dengan tim PKRS agar tidak hanya memberikan edukasi di ruang tunggu pasien tetapi juga dapat dilakukan di acara komunitas rumah sakit.

IX. MONITORING DAN EVALUASI

Tabel 8.1. Rekapitulasi Hasil Supervisi

No	STANDAR AKRE	Komponen	Dilakukan		Temuan Masalah	RTL	Prosentase	Total Prosentase
			Ya	Tidak				
1	TKRS 9	Terdapat Pedoman Pengorganisasian unit	√		Pedoman pengorganisasian sudah tersusun	-	100%	100%
		Terdapat Pedoman Pelayanan Unit	√		Pedoman pelayanan unit sudah tersusun	-	100%	
		Terdapat SPO Unit	√		SPO unit sudah tersusun	-	100%	
2	KPS 4	Terdapat SPK Bagi Ahli Gizi	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki SPK	-	100%	100%
		Terdapat RKK Bagi Ahli Gizi	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki RKK	-	100%	
3	KPS 5	Terdapat Evaluasi Kinerja Staf	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki evaluasi kinerja	-	100%	100%
4	KPS 6	Setiap Anggota Instalasi gizi memiliki file kepegawaian	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki file kepegawaian	-	100%	100%
		Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi staf (Ijazah Pendidikan terakhir)	√		5 dari 5 ahli gizi memenuhi Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi staf (Ijazah Pendidikan terakhir)	-	100%	
		Uraian tugas staf	√		-	-	100%	
		Penilaian kinerja staf	√		-	-	100%	

		Salinan sertifikat pelatihan di dalam maupun di luar rumah sakit yang telah diikuti.	√		-	-	100%	
		Informasi kesehatan yang dipersyaratkan, seperti vaksinasi/ imunisasi, hasil medical check up.	√		-	-	100%	
5	KPS 17	Melakukan Kredensial bagi Tenaga Kesehatan Lain	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki sudah melalui Kredensial bagi Tenaga Kesehatan Lain	-	100%	100%
		Bukti kredensial dicantumkan di file kepegawaian	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki Bukti kredensial	-	100%	
6	MFK 6	Pencegahan kebakaran, melalui cek pemasangan regulator elpiji, ketersediaan isi gas elpiji	√		-	-	100%	100%
		penyediaan titik evakuasi yang aman serta tidak terhalang apabila terjadi kebakaran	√		-	-	100%	
		Penyediaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi alarm kebakaran	√		-	-	100%	
		Penyediaan fasilitas pemadaman api secara aktif meliputi APAR, hidran, sistem sprinkler	√		-	-	100%	
		Melakukan pembersihan cerobong asap dan blower secara berkala	√		Pembersihan fasilitas dapur dilakukan setiap hari oleh CS pantry	-	100%	

		Pencegahan kebakaran, melalui cek pemasangan regulator elpiji, ketersediaan isi gas elpiji	√		Cek pemasangan regulator dilakukan setiap hari untuk mencegah kebocoran gas penyebab kebakaran	-	100%	
7	PMKP 4.1	Pasien yang mendapat diet sesuai	√		-	-	100%	91,73%
		Kejadian adanya benda asing dalam makanan	√		-	-	100%	
		Kejadian pasien tidak mendapat makan	√		-	-	100%	
		Kelengkapan pengkajian gizi	√		Terdapat 2 pasien yang belum dilakukan pengkajian gizi karena pasien pulang sebelum diedukasi gizi	Evaluasi rute keliling ahli gizi, mendahulukan pasien yang rencana pulang	99,8%	
		Kepatuhan kebersihan tangan		√	Petugas dapur dan penjamah makanan masih ada yang jarang melakukan cuci tangan sesuai dengan 5 moment dapur	Edukasi dan pemberian teguran kepada petugas yang tidak disiplin melakukan 5 moment	78,83%	
		Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) petugas pengolahan	√		Petugas pengolahan masih ada yang tidak menggunakan masker dengan alasan sakit di telinga jika menggunakan masker terlalu lama	Edukasi dan pemberian teguran kepada petugas yang tidak disiplin menggunakan masker	83,7%	
		Kepatuhan Identifikasi pasien	√		-	-	100%	
8	PMKP 9	Adanya kejadian yang tidak diharapkan (KTD)		√	Tanggal 1 Juni 2026 Pasien Ahmad hadi (C2A-	Memberikan teguran kepada petugas	96,6	97,98%

					1), pasien ob datang tgl 31 Mei jam 14.19 sehingga belum diberikan diet oleh ahli gizi, penyaji Duwi Ratna pada waktu membagi makan pagi tidak bertanya apakah pasien memiliki Dm atau tidak seperti update pasien pada umumnya jika diketahui pasien OB, pada waktu pagi hari diberikan teh manis dan diberikan snack non DM (setup pisang) yang menyebabkan gula darah pasien naik.	terkait perlunya konfirmasi saat pemebrrian makananan pasien		
		Adanya kejadian yang tidak cidera (KTC)		√	1. Tanggal 16 Juni 2026 Pasien Supinah (B5C-2) tidak derikan diet DM sejak MRS oleh ahli gizi (nurdyna) padahal ahli gizi sudah tau jika pasien memiliki RPD DM, diketahui saat ada pergantian diet menjadi cair sonde/NGT	Memberikan teguran kepada petugas terkait pelanggaran yang dilakukan	93,3 %	

					2. Tanggal 22 Juni 2026 pasien Sukemi (D8A-9) memiliki hasil lab Gula darah Sewaktu tinggi yaitu 284 mg/dl. Akan tetapi oleh ahli gizi Najiyatul diberikan diet TKTP RG yang seharusnya jika pasien GDS tinggi diberikan diet DM.			
		Adanya kejadian nyaris cedera (KNC)	√		-	-	100%	
		Adanya kejadian potensi cedera (KPC)	√		-	-	100%	
		Adanya kejadian sentinel	√		-	-	100%	
9	PPI 8	Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) pemilihan Bahan makanan	√		-	-	100%	98,77%
		Bahan pangan yang tidak dikemas berlabel berasal dari sumber yang jelas dipercaya, baik mutunya, utuh dan tidak rusak	√		-	-	100%	
		Bahan pangan kemasan harus mempunyai label, terdaftar atau ada ijin edar dan tidak kedaluwarsa, Pangan kemasan kaleng tidak menggelembung, bocor, penyok, dan berkarat.	√		-	-	100%	
		Jika bahan pangan tidak langsung digunakan maka bahan pangan harus diberikan label tanggal penerimaan		√	Masih ada bahan makanan yang tidak diberi	Mengarahkan petugas dapur untuk segera memberikan	88%	

		dan disimpan sesuai dengan jenis pangan			label saat setelah dibersihkan	label tanggal pembelian pada saat ditemukan tidak ada label tanggal pembelian		
		Bahan mentah dari hewan harus disimpan pada suhu kurang dari atau sama dengan 4 o C. Jika tidak memiliki lemari pendingin dapat menggunakan coolbox dan coolpack atau dry ice atau es balok yang dilengkapi dengan termometer untuk memantau suhu kurang dan atau sama dengan 4 oC	√		Pada tanggal 29 Mei 2026 Freezer penyimpanan daging tidak dingin. Suhu mencapai 9,5 °C	Koordinasi dengan tim IPSRS untuk memperbaiki freezer agar suhu mencapai standar	96,7%	
		Bahan pangan beku yang tidak langsung digunakan harus disimpan pada suhu – 10°C atau di bawahnya	√		-	-	100%	
		Penyimpanan harus menerapkan prinsip First In First Out (FIFO)	√		-	-	100%	
		Setiap bahan pangan ditempatkan secara terpisah dan dikelompokkan menurut jenisnya dalam wadah yang bersih, dan tara pangan (food grade)	√		-	-	100%	
		Ada catatan keluar masuknya bahan makanan	√		-	-	100%	
		Suhu gudang bahan pangan kering dan kaleng dijaga kurang dari 25 oC		√	Suhu gudang kering naik turun antara 25 -28°C	Memberikan kipas angin didalam gudang kering dan wajib menutup pintu saat keluar masuk untuk	88%	

					menjaga suhu gudang kering		
	Semua bahan pangan hendaknya disimpan pada rak-rak (pallet) dengan ketinggian atau jarak rak terbawah kurang lebih 15 cm dari lantai, 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit-langit.		√	jarak rak terbawah kurang dari 15 cm dari lantai	Koordinasi dengan tim IPSRS dalam memberi jarak penyimpanan makanan 15 cm dari lantai	96,6%	
	Rutin mengisi monitoring suhu setiap ruangan di instalasi gizi	√		-	-	100%	
	Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) pengolahan bahan makanan	√		-	-	100%	
	Bahan pangan yang akan digunakan dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir sebelum dimasak	√		-	-	100%	
	Pengolahan bahan makanan memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi	√		-	-	100%	
	Bahan pangan beku sebelum digunakan harus dilunakkan (thawing] sampai bagian tengahnya lunak,	√		-	-	100%	
	Pangan dimasak sampai matang sempurna	√		-	-	100%	
	Tempat/wadah penyimpanan terpisah dari setiap jenis makanan dan mempunyai tutup	√		-	-	100%	
	Makanan matang tidak dicampur dengan makanan mentah	√		-	-	100%	

		Adanya sample makanan yang disimpan 1 kali 24 jam	√		-	-	100%	
		Penyajian pangan matang harus bersih dan terhindar dari pencemaran.	√		-	-	100%	
		Pangan matang yang mudah rusak dan disimpan pada suhu ruang harus sudah dikonsumsi 4 jam setelah matang, jika masih akan dikonsumsi harus dilakukan pemanasan ulang	√		-	-	100%	
		Wadah/peralatan yang digunakan harus higienis, utuh, tidak cacat atau rusak	√		-	-	100%	
		Makanan disajikan tepat menu, tepat waktu, tepat tata hidang dan tepat volume (jumlah)	√		-	-	100%	
		Ada identitas pasien pada setiap box makanan pasien	√		-	-	100%	
10	PPI 11	Cek kesesuaian hand hygiene setiap selesai melakukan kegiatan yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana melakukan cuci tangan menggunakan hand wash dan hand rubs	√		Petugas penjamah makanan masih belum disiplin dalam melakukan hand hygiene	Memberikan teguran dan Sosialisasi tentang hand hygiene kepada penjamah makanan.	78,83%	92,94%
		Cek kelengkapan fasilitas hand hygiene antara lain sabun, desinfektan, serta tisu/ handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan desinfeksi tangan	√		-	-	100%	

		Cek pelaksanaan pelatihan tentang hand hygiene untuk semua petugas gizi	√		-	-	100%	
11	PPI 11.1	Cek pelaksanaan pelatihan tentang penggunaan APD untuk semua petugas gizi	√		-	-	100%	99,6%
		Cek kepatuhan penggunaan APD	√		-	-	99%	
		Cek ketersediaan alat pelindung diri/ APD	√		-	-	100%	
12	PP 1.2	Adanya regulasi tentang kriteria risiko nutritional	√		-	-	100%	100%
		Adanya bukti Rekam Medis pengkajian awal skrining risiko nutrisi.	√		-	-	100%	
		Bukti Rekam Medis pengkajian gizi untuk pasien dengan risiko nutrisional.	√		-	-	100%	

Analisis :

1. Dari hasil supervise terkait regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi tidak ditemukan temuan khusus yang bertentangan dengan regulasi pelayanan gizi dengan prosentase 100%.
2. Dari hasil supervise terkait Sarana dan prasarana RS ditemukan jarak penyimpanan bahan makanan kering dari lantai kurang dari 15 cm dan perlu segera ditindaklanjuti agar masa simpan bahan makanan lebih lama
3. Dari hasil supervisi tentang PMKP didapatkan peningkatan kepatuhan penggunaan APD, jenis APD yang masih jarang digunakan adalah masker.
4. Dari hasil supervisi kepatuhan cuci tangan perlu adanya peningkatan kesadaran penjamah makanan dalam praktik hand hygiene untuk menjamin kebersihan makanan pasien
5. Dari hasil supervisi terkait PPI patuh dalam penggunaan APD, namun belum patuh cuci tangan, pemberian label pada makanan matang tidak langsung digunakan, dan tidak disiplin dalam menutup pintu gudang kering saat keluar masuk gudang sehingga mengakibatkan suhu gudang kering tinggi.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

1. Pertahankan pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan gizi rumah sakit.
2. Kepatuhan dalam mengerjakan asuhan gizi di rekam medis harus dipertahankan dengan cara lebih teliti lagi, dan jika mengerjakan tidak boleh terburu-buru.
3. Mengupdate ilmu gizi dengan mengikuti pelatihan eksternal maupun internal yang diadakan oleh rumah sakit.
4. Identifikasi pasien saat memberikan edukasi, mendistribusikan makanan kepada pasien wajib dilakukan oleh seluruh petugas.
5. Kepatuhan penggunaan APD lebih ditingkatkan lagi dengan cara mengshare nama - nama petugas yang tidak patuh setiap bulannya dan data dikirimkan ke SDM.
6. Kepatuhan petugas dapur dan juga penjamah makanan harus lebih ditingkatkan lagi agar dikemudian hari tidak ada kontaminasi silang ke pasien karena ketidak patuhan petugas dengan cara sosialisasi pentingnya HH dan 5 momen, membersihkan lingkungan dapur setiap selesai kegiatan, meletakkan bahan makanan yang baru datang di tempat yang sudah ditentukan (bahan basah dimasukkan ke gudang beku, bahan kering dimasukkan kedalam gudang kering) dengan system FIFO dan FEFO.
7. Kepatuhan dalam pengisian form keluar masuk alat makan harus dihitung dengan benar dan tidak boleh dirapel, mengshare nama petugas yang tidak patuh dalam pengisian.
8. Kepatuhan dalam mengembalikan tirai PVC setelah membersihkan area gizi agar tirai tidak rusak karena di singkap dan diletakkan dengan posisi tidak pada tempatnya.
9. Kepatuhan dalam pengisian suhu ruangan tidak boleh dirapel, agar hasil yang didapat valid dan jika ada masalah bisa segera di TL. Mengshare nama petugas yang tidak patuh dalam pengisian.
10. Review sosialisasi terkait pentingnya APD, HH dan pengisian suhu harus diberikan setiap satu bulan sekali saat rapat bulanan unit.
11. Pintu penerimaan bahan makanan dan pintu ruang ganti karyawan wajib ditutup setelah keluar masuk, agar vector yang dari luar tidak masuk ke area instalasi gizi.

Tabel 8.2. Komplain Gizi

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Desember 2025	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026
2.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	0	1	1
	ISI KOMPLAINAN	- Pasien V2 lantai 2c bernama Zhafran Alkhairy (5 Februari 2026) mendapatkan menu perkedel pada hari tersebut. Keluarga pasien komplain terkait perkedel yang asam. Dan menu penunggu untuk pasien VIP mengapa sama dengan makan pasien.		
	Analisis	- Pemilihan kentang yang baik berpengaruh pada hasil matang, karena banyak ditemukan kentang yang datang bertekstur lunak saat setelah dikupas. - Mengkaji dan memberi usulan menu kepada pemegang kebijakan.		
	RTL	- Memilih dan menerima bahan makanan basah sesuai spesifikasi - Mengajukan usulan menu baru kepada pemegang kebijakan disertakan dengan bukti.		
No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026	Jumlah Komplain Bulan Maret 2026
3.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1	1	2
	ISI KOMPLAINAN	- Pasien 4A atas nama Bu Krisna komplain makan pagi tidak ada nasi. - Pasien 4A atas nama Pak Jahman komplain makanan bekas pasien lain diberikan kepada pasien.		
	Analisis	- Tidak dilakukan check ulang sesudah pemberian nasi. - Penyaji Tiyas kehabisan makanan untuk pasien baru, sehingga meminta kepada penyaji Dwi Ratna untuk meminta cadangan makan lantai yang dibagi. Dwi Ratna memberikan cadangan makan tanpa		

		dicheck dahulu. Dan penyaji Tiyas menerima tanpa mencheck dahulu juga, sehingga box makan diterima pasien dalam keadaan sudah dimakan.
	RTL	- QC makanan sebelum ditutup, harus dilakukan double QC. - Perlu adanya check ulang sebelum pendelegasian kepada teman, dan teman yang menerima harus melakukan check ulang kembali.

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026	Jumlah Komplain Bulan Maret 2026	Jumlah Komplain Bulan April 2026
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1	2	0
	ISI KOMPLAINAN	- Tidak ada komplain terkait makanan pada bulan april		
	Analisis	-		
	RTL	-		

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Maret 2026	Jumlah Komplain Bulan April 2026	Jumlah Komplain Bulan Mei 2026
1.	Benda asing dalam makanan pasien	2	0	1
	ISI KOMPLAINAN	Keluarga pasien atas nama Dian Indriani komplain terkait ditemukannya benda asing (kecoak) pada snack pasien (roti bolu),		
	Analisis	Penyaji tyas mengakui sudah memorsi snack sejak sore tanggal 28/05/2026 kemungkinan kecoak masuk pada malam hari.		
	RTL	Memberikan teguran terkait pemorsian snack yang tidak sesuai SOP		

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan April 2026	Jumlah Komplain Bulan Mei 2026	Jumlah Komplain Bulan Juni 2026
1.	-	0	1	0
	ISI KOMPLAINAN	-		
	Analisis	-		

XI. PENUTUP

Dari hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan petugas gizi dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit. Namun untuk petugas penjamah makanan perlu dilakukan supervise lebih lanjut secara berkala agar kepatuhan dalam menggunakan APD dan kebersihan tangan dapat ditingkatkan.

Adanya monitoring secara berkala dari kepala unit maupun jajaran manajemen diatasnya dapat meningkatkan kepatuhan dari petugas unit gizi.

Mengetahui
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

Malang, 04 Juli 2026
Kepala Unit Gizi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ericha Risdawati'.

Ericha Risdawati, A.Md. Gz

A. LAMPIRAN KUANTITAS SDM

Tenaga Gizi *) Ditampilkan 3 bulan terakhir

No .	Jenis Tenaga	April			Mei			Juni		
		Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total
1.	Nutrisionis	-	5	5	-	5	5	2	3	5
Total		-	5	5	-	5	5	2	3	5

Tenaga Dapur *) Ditampilkan 3 bulan terakhir

No .	Jenis Tenaga	April			Mei			Juni		
		Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total
1.	Pengolah Makanan	2	2	4	2	2	4	2	2	4
2.	Penyaji Makanan	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Total		8	2	10	8	2	10	8	2	10

A. LAMPIRAN KUALITAS SDM

No.	Nama	PK	Jabatan	Skill	Knowledge	Attitude							Catatan
						J	T	V	D	K	A	P	
1.	Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
2.	Chandrawati M., S.Tr.Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3.	Nafisah Ulfa H, S.Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
4.	Najiyyatul Fithriyyah., S.Tr.Gz		Pelaksana Gizi	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
5.	Nurdyna Zahro Latifa, Amd. Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
6.	Suryani	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	C	C	C	B	C	
7.	Deri Untari	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8.	Siti Sulistyowati	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9.	Suriyanti	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	C	B	B	B	
10.	Della Karisma Zakenda	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
11.	Riski Dwi Andriani	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
12.	Dewinta Laili Rahmadia	-	Pelaksana Dapur	C	B	B	B	C	B	B	B	B	
13.	Sabrina Nasywa Mufida	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	C	C	C	
14.	Duwi Ratna Yulianti	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	C	B	B	
15.	Tiyas Ninda Ekasari	-	Pelaksana Dapur	B	C	B	C	B	C	C	B	B	

Keterangan: B = Baik
C = Cukup
K = Kurang

B. LAMPIRAN MUTU UNIT

No.	Indikator	Standar	Hasil											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	100%	89,9%	87,8%	58,27%	66,7%	83,7%	-	-	-	-	-	-
2.	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
3.	Angka kelengkapan asuhan gizi	100%	99.8%	100%	100%	99,9%	99,7%	99,8	-	-	-	-	-	-
4.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	2	2	1	0	1	3	-	-	-	-	-	-
5.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-
6.	Kejadian makanan basi	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

C. LAMPIRAN KEUANGAN UNIT GIZI (DAPUR)

[illegible]

No	Keterangan	Nominal							Total
		22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	
	Pengeluaran :								
1	Bahan Makan Pasien	1680000	1809000	2616000	1722600	0	0	2220000	10047600
2	Bahan Makan Karyawan	560000	603000	872000	574200	0	0	740000	3349200
3	Bahan Makan Rumah Tangga	140000	150750	218000	143550	0	0	185000	837300
4	Bahan Makan Tamu	420000	452250	654000	430650	0	0	555000	2511900
		2800000	3015000	4360000	2871000	0	0	3700000	0
									16746000
No	Keterangan	Nominal							Total
		29/06/2026	30/06/2026						
	Pengeluaran :								
1	Bahan Makan Pasien	1800000	1010400						2810400
2	Bahan Makan Karyawan	600000	336800						936800
3	Bahan Makan Rumah Tangga	150000	84200						234200
4	Bahan Makan Tamu	450000	252600						702600
		3000000	1684000						4684000
									4684000

LAMPIRAN PENGELUARAN UNIT DAPUR 2026

NO	BULAN	TOTAL PENGELUARAN
1	Januari	Rp. 83.667.200
2	Februari	Rp. 76.391.500
3	Maret	Rp. 81.800.339
4	April	Rp. 67.920.334
5	Mei	Rp. 62.338.779
6	Juni	Rp. 15.325.000
7	Juli	-

8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-

D. LAMPIRAN FOOD WASTE (SISA MAKANAN)

Siklus menu pada bulan Maret

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	
1.	Karbohidrat	Nasi	68,8	74,7	64,8	75,5% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan April 2026 meningkat 0,5% dari bulan Maret 2026. Perlu adanya evaluasi pemorsian KH pada menu pasien
		Nasi Tim	98,8	91,7	90,6	
	Total		138	166,1	155,4	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang
		Setup Pisang	0	0	0	
		Kacang Hijau	0	0	0	
		Kue Hongkong	0	0	0	pada bulan April tidak ada sisa yang kembali dari pasien diakarenakan pasien memindahkan snack yang masih ada kedalam wadah pribadi saat pengambilan alat makan snack pasien
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	0	0	0	
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0	0	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0	0	
		Brule Bomb	0	0	0	
	Total		0	0	0	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret.
	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,8	4,1	5,1	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	4,5	3,8	4,9	
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok				
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)	4,2	3,7	3,8	
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon				
	Total			12,5	11,6	
2.	Menu 2					

	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4,7	3,5	4,8
		Tahu Rempah (Remet)			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Rebus			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	4,6	3,7	6
		Ayam Wijen			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Telur Gulung			
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)	4,2	3,3	5,3
		Telur dadar tebal			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
	Total		13,5	10,5	16,1
3.	Menu 3				
	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	4,2	3,7	6,5
		Tahu Krispy			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	4	3,9	4,1
		Rolade Ayam			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	0,5	3,9	3,7
		Telur rebus			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
	Total		8,7	11,5	14,3
4.	Menu 4				

Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026
Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,8	4,8	4,3
	Tahu Nugget			
	Abon			
Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,2	3,8	4,2
	Ayam Kecap			
	Jamur Krispy			
Tambahan VIP	Tahu Bacem			
Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sas u polong orang	0,9	4	3,8
	Jamur goreng			
Tambahan VIP	abon			
Total		8,9	12,6	12,3
5.	Menu 5			
Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026
Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	2,7	4,5	3,9
	Opor Tahu			
	Oper Telur			
Tambahan VIP	Tempe Goreng			
Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,9	3,6	2,9
	Ayam Bombay			
	Bakwan Jagung			
Tambahan VIP	Tahu Krispy			
Sore	Soto ayam	4	2,8	3
	Telur rebus			
	VIP= Perkedel ayam			
Total		9,9	10,9	9,8
Total Sisa Menu tanpa KH		53,3	54,2	66,3
Total Keseluruhan dengan KH		191,3	221,8	221,7

3.2.5.10 Tabel Rekap Food Waste pada Tahun 2026

No	Bulan	Total Makanan keluar (kg)	Total Sisa Makanan (kg)	%sisa makanan (standar <20%)
1.	Januari 2026	-	218,8	-
2.	Februari 2026	-	191,3	-
3.	Maret 2026	-	185,7	-
4.	April 2026	-	221,8	-
5.	Mei 2026	1676,6	223,5	7,5%
6.	Juni 2026	1767,5	221,7	7,9 %
7.	Juli 2026		-	
8.	Agustus 2026		-	
9.	September 2026		-	
10.	Oktober 2026		-	
11.	November 2026		-	

E. LAMPIRAN PEMANTAUAN AIR PANAS DI PENCUCIAN ALAT MAKAN

			KUMAH SANTU PRIMA HUSADA		
			Monitoring Suhu Air Panas (Suhu Normal = 75° - 80° Celcius)		
			TANGGAL		
			1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
			15		
			16		
			17		
			18		
Batas suhu min (°C)			75	75	75
Batas suhu maks (°C)			80	80	80
Nilai Suhu (°C)			57	57	85
Inisial Staff			an	an	an
Supervisi Karu			V	V	V
Ket :			1. Isi dengan angka yang sesuai pada kolom suhu (°C) sebagai tanda ukuran suhu pada tanggal tersebut, grafik secara otomatis akan terbentuk.		
			2. Tuliskan inisial staf yang melakukan pencatatan dan akan di supervisi (v) oleh kepala ruang setiap harinya		
					
19			20		
21			22		
23			24		
25			26		
27			28		
29			30		
31					
P			P	S	Sr
75			75	75	75
80			80	80	80
85			84	84	84
slm			slm	slm	dn
V			V	V	V
(---) Suhu air panas tidak lebih dari 80°C			(---) Suhu air panas tidak kurang dari 75°C		

F. LAMPIRAN KEHILANGAN/KERUSAKAN ALAT MAKAN

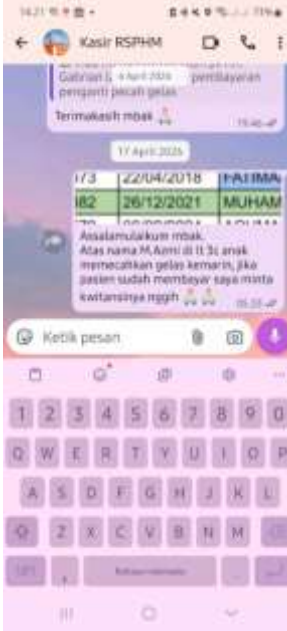
DATA NAMA PASIEN MENGHILANGKAN / MERUSAKKAN ALAT							
NO.	TANGGAL	RUANGAN	NAMA PASIEN	KWITANSI	DOKUMENTASI	Nama Alat	KET
DESEMBER 2025							
1	01/12/2025	C3C-3	SYABIL ISMAIL DWIFARO	-	-	GELAS	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar pergantian ke kasir
JANUARI 2026							
1	06/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas tiba-tiba retak, tidak layak pakai
2	12/01/2026	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.

3	13/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas mengalami pemuaian saat diangkut oleh CS dan pecah di trolly.
4	17/01/2026					SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok makan sudah tidak layak pakai karena berkarat.
5	20/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	

6	20/01/2026	D7A-5	Bakri	-		BOX MAKAN PECAH	Pasien memecahkan box makan merah, namun pasien tidak bersedia membayar dan pulang.
7	21/01/2026	C4B-3	Amelia Novita Sari	-		SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok hilang terbawa pasien pulang
8	27/01/2025	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.

9	30/01/2026	D6A-2	Sukirno	-		SENDOK MAKAN PASIE	Sendok hilang terbawa pasien pulang
FEBRUARI 2026							
1.	06/02/2026	-	-	-		GELAS PASIE	Saat menuangkan teh, gelas retak. Sudah tidak layak pakai
2.	07/02/2026	C4A-2	HADI SUTRISNO			GELAS PASIE	Pasien memecahkan gelas dan sudah dibayar
3.	15/2/2026	-	-	-		MANGKOK KECIL SNACK	Pecah oleh penyaji Tiyas
MARET 2026							

1.	08/03/2026	-	-	-		Box merah	Box merah pecah
2.	11/03/2026	D6A-12	MIFTAKHUL JANAH			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir
3.	22/03/2026	ICU	SARMI KUSUMAWATI			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir
APRIL 2026							

4.	06/04/2026	3c Anak	GABRIAN		Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir
5.	17/04/2026	3C ANAK	M.AZMI		Gelas pasien	Pasien pulang tidak membayar kerusakan alat ke kasir
6	06/04/2026	-	-	-	gelas	gelas pecah
7	17/04/2026	-	-	-	gelas	gelas pecah

8	28/04/2026	-	-	-		box merah	Box merah pecah
---	------------	---	---	---	---	-----------	-----------------

9	17/04/2026	-	-	-		box merah	Box merah pecah
---	------------	---	---	---	---	-----------	-----------------

MEI							
10	14/05/2026	D7A-10	GABRIELLA PERMATA SINA			SENDOK MAKAN	SENDOK HILANG PASIEN PULANG TANPA MENGGANTI

11	10/05/2026	-	-	-		BOX MERAH	BOX MERAH PECAH
JUNI 2026							
12	03/06/2026	D8A-5	SUWITO			GELAS	PASIEN PULANG MENGHILANGKAN SENDOK

13	12/06/0206	A1(VIP)	ABDULLAH FATHIR ABHIMATA			GELAS	PASIEN MEMECAHKAN GELAS
14	18/06/2026	C4B-2	BILQIS LUBNA KAMILIA		-	GELAS	PASIEN MEMECAHKAN GELAS SUDAH MEMBAYAR PERGANTIAN
15	21/06/2026	C4A-7	SAHRUL GUNAWAN		-	SENDOK	PASIEN MENGHILANGKAN SENDOK SUDAH LUNAS KASIR
